

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

Stigmatisierung verhindern

**–
Respekt vor
kranken Menschen stärken**

**–
personenzentriert betreuen**



Immer mehr Menschen in unserer Betreuung leiden an psychiatrischen/gerontopsychiatrischen Erkrankungen bzw. Veränderungen und werden in teil – und vollstationären Einrichtungen fachlich qualifiziert betreut.

Insbesondere orientieren wir uns an Veränderungen und Erkrankungen die in den Diagnosesystemen des ICD-10 bzw. DSM-5 beschrieben sind.

Zu den Zielgruppen dieses Konzeptes gehören:

- Menschen mit psychiatrischen Veränderungen und Erkrankungen/Diagnosen
- deren Bezugspersonen, Angehörige
- Mitarbeiter der unterschiedlichen Pflege-, Betreuungs- und Versorgungsbereiche
- ehrenamtliche Helfer sowie
- interne und externe Kooperationspartner

Ein wichtiges Ziel unseres Leitbildes ist es, die Menschen in unserer Betreuung mit Würde zu behandeln und auf deren subjektives Wohlfühlen zu achten (personenzentrierter Ansatz).

Person – zentriert zu handeln ist unser Anspruch als Pflegedienst und gilt nicht nur für die von uns betreuten Menschen mit psychiatrischen Veränderungen, sondern bedeutet für uns auch Mitarbeiter als wichtigen Bestandteil des Pflege- und Betreuungsprozesses mit einzubeziehen.

Bei der Umsetzung der Person-Zentrierung achten wir vor allem auf die Stärkung der Menschenwürde und positive Beziehungsgestaltung. Wir erkennen die Einzigartigkeit und die Individualität des Menschen an.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	I	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

Bei der Anwendung des Expertenstandards „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ orientieren wir uns an Menschen mit psychiatrischen Veränderungen und Erkrankungen und hierbei besonders an Menschen mit diagnostizierten Demenzerkrankungen und Menschen bei denen sich zu Beginn des pflegerischen Auftrages Anzeichen von Demenzen zeigen, ohne dass eine Demenzdiagnose vorliegt.

„Jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz erhält Angebote zur Beziehungsgestaltung, das, das Gefühl gehört, verstanden und angenommen zu werden sowie mit anderen Personen verbunden zu sein, erhalten und fördern.“ (Zielformulierung des Expertenstandards)

Unser Ziel ist es Wohlbefinden herzustellen und deren individuelle Sicht trotz Einschränkungen wahrzunehmen und anzuerkennen. Wir unterstützen Menschen ihre Selbstbestimmung wahrzunehmen sowie Partizipation und Teilhabe unter Berücksichtigung aller Bedürfnisse zu erleben.

Wir vermitteln den Angehörigen, warum sich der Patient so verhält bzw. sich so verändert hat, mit dem Ziel, den Kontakt zwischen den Betroffenen und den Angehörigen nicht abreißen zu lassen. (Information, Beratung, Anleitung)

In jeder Phase des Lebens ist das Selbstbestimmungsrecht zu achten, es kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt sein (z.B. Selbstgefährdung, Gefährdung Dritter, Betreuungsrecht).

Alle Mitarbeiter lassen sich von folgenden Grundsätzen des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, KDA, Köln, 2000) leiten:

- lerne die Persönlichkeit deines Bewohners kennen,
- Sorge für kleine und wohnliche Organisationseinheiten und dafür, dass Bewohner feste Bezugspersonen unter den Mitarbeitern haben,
- stelle die Bewohner in den Mittelpunkt deines Tuns,
- öffne Türen zum Bewohner und vermeide türschließendes Verhalten bei dir selbst und bei anderen,
- verbinde dein Wissen mit dem Wissen anderer Berufsgruppen und arbeite mit ihnen zusammen,
- informiere dich über (psychiatrische) Krankheitsbilder und Verhaltensweisen, bilde dich gezielt und sinnvoll weiter.

In unserem Pflegedienst ist folgende MitarbeiterIn, mit einer abgeschlossenen Ausbildung als psychiatrische/gerontopsychiatrische Pflegefachkraft eingesetzt und verfügt über das notwendige Wissen und Fähigkeiten. Sie ist auf der übergeordneten Ebene zuständig für die Betreuung der Teams die in der Pflege von Menschen mit Demenz arbeiten:

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

- Frau/Herr

Alle Mitarbeiter, die an der Versorgung mit Demenz beteiligt sind, nehmen an fachspezifischen Schulungsmaßnahmen teil.

In unserer Einrichtung sind unterstützende Mitarbeiter tätig (siehe Pkt. II.2 des QM-Handbuches).

Die vereinbarten Stellen sind besetzt, diese Mitarbeiter verfügen über die notwendigen Qualifikationen und Weiterbildung. Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Schulung für diese Mitarbeiter.

Dieses pflegerisch-psychiatrische Konzept berücksichtigt folgende nachstehende Dokumente:

- die jeweils gültige QPR/MDK-Prüfanleitung
- die „Rahmenempfehlung des BMG zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Demenz in der stationären Altenhilfe“ 2006
- Regelungen des § 45a SGB XI
- die Grundsatzstellungnahme des MDS Essen „Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz in stationären Einrichtungen“ 12/2009
- S 3 Leitlinie Demenzen 11/2009 der Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN)“, „Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)“ in Zusammenarbeit mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. – Selbsthilfe Demenz
- Gültige ICD-10 Diagnosebeschreibungen der Kategorie F
- das für das Land gültige PsychKG (Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen)
- der Nationale Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ (2018)
- die Grundsatzstellungnahme des MDS Essen „Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ (2019)

Grundsatz:

Pflegefachkräfte stellen keine ärztliche psychiatrische/gerontopsychiatrische Diagnose, leisten jedoch eine wichtige Zuarbeit für die ärztliche Diagnosestellung.

Pflegefachkräfte (PFK) erheben Abweichungen, dokumentieren diese und stellen diese Informationen dem Facharzt zur Verfügung. Informationen sind von allen PFK/PHK und Betreuungskräften zu erheben.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

Die Durchführung von Tests sowie die Endbewertung inklusive der Mitteilung an den Facharzt erfolgen durch die PFK.

<u>Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln</u>	
Unterstützung in Diagnostik und Therapie	
Baustein Biografie	Baustein Normalität
Baustein Humor	Baustein Erfahrungslernen
Versuch und Irrtum	
Messen von Wohlfühlen und DiStress mit Maßnahmeplanung	

Umsetzung des Konzeptes

Durchführende:

- Pflegefachkräfte/Pflegehilfskräfte/Betreuungskräfte

Pflegeziel:

- Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
- Emphatischer Umgang mit psychiatrischen Störungen von Patienten

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	4	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

- Erhöhung des Verständnisses von Angehörigen für die Lebenssituation der Bewohner

Indikation:

- bei psychiatrisch indizierten Auffälligkeiten/Veränderungen (Symptome)
- bei diagnostizierten psychiatrischen Erkrankungen

Kontraindikation:

- bei Ablehnung durch den Patienten

Durchführung:

- im Rahmen der Krankenbeobachtung Feststellen von Symptomen die auf eine psychiatrische Veränderung (erstmalig, Verschlechterung von bekannten Veränderungen, zur Evaluation) hinweisen, wie bspw. komplexe Aufmerksamkeit, exekutive Funktionen, Lernen und Gedächtnis, Sprache, perzeptuell-motorische Fähigkeiten, soziale Kognition etc.
- Durchführung einer Fallbesprechung mit anderen Mitarbeitern zur Bestätigung der erhobenen Informationen
- Information an die PDL
- Dokumentation im Pflegebericht
- bei Ablehnung durch den Patienten Bewerten der Situation und Abstimmen mit dem Arzt sowie der PDL zum weiteren Vorgehen, auch unter Beachtung von Regelungen des Betreuungsrechtes
- Erhebung von Informationen zu möglichen Ursachen, Nutzung möglicher im Einzelfall angezeigter Tests
- enge Abstimmung zum gemeinsamen Vorgehen mit dem Arzt (Therapie-Monitoring)
- Umsetzung der Festlegungen des Arztes bzw. eigener festgelegter adäquater pflegerischer –psychiatrischer Maßnahmen anhand der festgestellten personenzentrierten Unterstützungsbedarfe (bspw. Dehydratation, Medikamentenintoxikation, Umsetzung Betreuungskonzepte)
- es gilt Versuch und Irrtum um passende sozial adäquate als angenehm wahrgenommen Situationen herzustellen und DiStress zu vermeiden.
- das Feststellen, Bewerten und die Evaluation von Wohlfühl- und DiStress-Zuständen und deren Dokumentation erfolgt mit dem festgelegten Nachweis (bspw. ELLINOR) sowie dem Therapie-Monitoring mit dem Arzt und der Bewertung der Wirksamkeit pflegerischer Maßnahmen.
- Die Beratung und Information von Betroffenen und Angehörigen soll zu Beginn und bei Veränderungen erfolgen. Das Beratungsblatt (siehe Anlage) ist als Nachweis zu nutzen.
- Festhalten der Maßnahmen in der Pflege-/Maßnahmeplanung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	5	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

Mögliche kognitive Tests können sein:

- der Mini-Mental-Status-Test (MMST),
- die Cohen-Mansfield-Skala,
- bei Patienten, die nicht rechnen und schreiben können – Uhrentest,
- bei Patienten bei denen auch der Uhrentest nicht angewendet werden kann (kann keine Uhr lesen) erfolgt die Bewertung im Rahmen der Krankenbeobachtung.
- Modul „kognitive und kommunikative Fähigkeiten“ und „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ des Begutachtungsinstruments (BI)
- EASY – kulturneutraler Test für Menschen mit Migration
- Klinische Beurteilung (Krankenbeobachtung)

In der Beziehungsgestaltung sind folgende Dimensionen sind zu berücksichtigen bzw. zu bewerten:

1. „Jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz erhält Angebote zur Beziehungsgestaltung, die das Gefühl gehört, verstanden und angenommen zu werden sowie mit anderen Personen verbunden zu sein, erhalten oder fördern.“
2. Komplexe Aufmerksamkeit
3. Exekutive Funktionen
4. Lernen und Gedächtnis
5. Sprache
6. Perzeptuell-motorische Fähigkeiten
7. Soziale Kognition

Wir minimieren Patienten nie nur auf eine Diagnose. Diagnosen stellen nur den negativen Anteil von Erkrankungen und deren zukünftiger möglicher Entwicklung dar. Ressourcen, positive Anteile und Entwicklungen sind nicht Teil einer Diagnose.

Dies bedeutet den Patienten immer als selbständig handelnden Menschen wahrzunehmen. Er ist mit Würde anzusprechen. Assistenz gibt es nur dort wo Hilfe notwendig ist. Keiner wird herabwürdigend stigmatisiert. Unsere Kommunikationsformen sind auf den Einzelfall adäquat angepasst. Wir orientieren uns solange dies möglich ist am Realitäts-Orientierungs-Training (ROT) bzw. Selbsterhaltungstraining (SET).

In der Betreuung orientieren wir uns vor allem an folgenden Konzepten, hierbei ist es möglich, dort wo angezeigt, auch nur Teile dieser Konzepte anzuwenden. Es gilt Versuch und Irrtum:

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	6	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

Die PFK/PHK bzw. Betreuungsperson legt für sich fest, welches Konzept oder welche Anteile aus den Konzepten im Einzelfall angewendet werden (können).

Wir orientieren uns an den Grundsätzen der Lebensweltorientierung, Wahrnehmungsförderung, Wertschätzung und Zuwendung sowie der Umsetzung spezifischer Maßnahmen:

- Umsetzung der Betreuungskräfterichtlinie
- Milieuthapie
- personenzentrierte Pflege nach Kitwood (mit DCM)
- Nice-Leitlinie 42
- Palliativpflege, Schmerzmanagement und Pflege am Lebensende bei Demenzkranken
- Validation
- Erlebnisorientierte Pflege (Mäeutik) bspw. familienähnliche Esssituationen können Essverhalten positiv beeinflussen (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)
- Aroma-Pflege bei mittel- bis schwergradiger Demenz (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)
- Psycho-Biografisches Modell nach Erwin Böhm
- Realitätsorientierungstraining (ROT)
- Einsatz von ergotherapeutischen individuell angepassten Maßnahmen bei leichter bis mittelschwerer Demenz, Bewegung, körperliche Aktivitäten (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)
- eine angemessene strukturierte soziale Aktivierung während des Tages kann zur Verbesserung des Tag-Nacht-Schlafverhältnisses führen (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)
- Reminiszenztherapie (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen), auch vor dem Hintergrund von Migration und Wanderungsbewegung
- Erinnerungspflege, auch vor dem Hintergrund von Migration und Wanderungsbewegung
- 10-Minuten-Aktivierung
- Therapeutischer Tischbesuchsdienst
- Tiere im Heim
- Snoezelen bei moderater bis schwerer Demenz (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)
- Musik in der Pflege mit biografischem Bezug (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)
- Humor in der Pflege
- Angebote kognitiver Stimulation bei leichter bis moderater Demenz. (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)
- Unterstützungsprogramme für Pflegenden/Betreuende bei depressiven Symptomen (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	7	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

- Angehörigen-Edukation, Angehörigentraining zum Umgang mit psychischen und Verhaltenssymptomen bei Demenz (empfohlen S3 Leitlinie Demenzen)
- Normalitätsprinzip nach Averosa
- hauswirtschaftliche, handwerkliche Aktivitäten im Rahmen des Erhalts von Ressourcen
- sensorische Verfahren: snoezeln, basale Stimulation, Massagen, Körperstimulation, haptisch, oral)
- Hinweise der „Rahmenempfehlung des Bundesministeriums für Gesundheit zum Umgang mit herausforderndem Verhalten“
- Konversation
- Arbeit mit Puppen, Arbeit mit Schein- und Nebenwelten
- Einsatz von Sozial-Robotern (bspw. Robbe), jedoch nicht als Ersatz von normaler Kommunikation
- Künstlerisch: tanzen, Theaterspiel, Musik, singen, malen, modellieren
- Unter Anleitung Einsatz Nutzung von Technik bspw. Tablet-PC
- Erzählen von Märchen und Geschichten, Imaginationen, Arbeit mit Clowns
- Sicherung einer auf Wohlbefinden ausgerichteten psychosozialen Interaktion und eines psychosozialen Klimas
- Stärkung der Mobilität

Unsere Leistungen sind in unserem genehmigten Konzept beschrieben.

bspw.

-  Malen und basteln,
-  Handwerkliche Arbeiten und leichte Gartenarbeiten,
-  Haustiere füttern und pflegen, tiergestützte Intervention
-  Kochen und backen,
-  Anfertigung von Erinnerungsalben oder -ordnern,
-  Musik hören, musizieren, singen,
-  Brett- und Kartenspiele,
-  Spaziergänge und Ausflüge,
-  Bewegungsübungen und Tanzen in der Gruppe,
-  Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Gottesdiensten und Friedhöfen,
-  Lesen und Vorlesen,
-  Fotoalben anschauen

Die Betreuungskräfte sollen den Patienten für Gespräche über Alltägliches und ihre Sorgen zur Verfügung stehen, ihnen durch ihre Anwesenheit Ängste nehmen sowie Sicherheit und Orientierung vermitteln.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	8	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

Betreuungs- und Aktivierungsangebote sollen sich an den Erwartungen, Wünschen, Fähigkeiten und Befindlichkeiten der Patienten unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Biographie, ggf. einschließlich ihres Migrationshintergrundes, dem Geschlecht sowie dem jeweiligen situativen Kontext orientieren.

Die Durchführung der Leistungen ist zu dokumentieren.

Räumlichkeiten/Aufenthalt im Freien

Wir versuchen Patienten oft ins Freie zu begleiten. Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien (Wohnbereich) sind vorhanden und gesichert.

Die Umsetzung von Vorgaben nach dem PsychKG

Durchführende:

- PFK/PHK/PDL

Maßnahmen:

- Eine Unterbringung ist nur zulässig, wenn und solange die gegenwärtige erhebliche Gefahr besteht, daß der Betroffene sich infolge einer Krankheit, Störung oder Behinderung schwerwiegende gesundheitliche Schäden zufügt, oder das durch die Krankheit, Störung oder Behinderung bedingte Verhalten des Betroffenen aus anderen Gründen eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt, und die Gefahr auf andere Weise nicht abgewendet werden kann. Liegen die vorgenannten Anhaltspunkte vor, hat die zuständige PFK sich mit anderen Mitarbeitern im Rahmen einer Fallbesprechung abzustimmen und die PDL zu informieren, die Fallbesprechung mit dem Ergebnis ist zu dokumentieren
- es hat eine Abstimmung dem behandelnden Arzt zu erfolgen/Notarzt
- die PDL hat umgehend bei der zuständigen Stelle einen Antrag auf Unterbringung nach dem PsychKG zu stellen
- bei Gefahr im Verzug hat die PDL alles zu unternehmen um Gefährdungen/ Eigengefährdungen des Patienten zu vermeiden und unter Umständen die Polizei/ den Notarzt beizuziehen
- Anträge und weitere Unterlagen sind in der Patientenakte/Verwaltung abzulegen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	9	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

Name/Vorname des Patienten:	Name/Vorname des Angehörigen/Betreuers:
------------------------------------	--

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Angehörige,

dieses Dokument soll Sie und Ihre Angehörigen über Risiken zum Umgang mit pflegerisch-psychiatrischen Auffälligkeiten und Veränderungen informieren und beraten.

Ihnen ist bekannt, dass Sie/ Ihr/e Angehörige/r an folgender pflegerisch-psychiatrischer Erkrankung leidet:						
Vorstellung der wichtigsten Krankheitssymptome dieser Krankheit:						
Mögliche Ursachen:						
Darstellung von Möglichkeiten der Betreuung durch unseren Pflegedienst, inklusive kurzer Erläuterung der genutzten Konzepte:						
Feststellung zu individuellen Besonderheiten:						

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	10	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: IV.6	Bezeichnung des Dokumentes: Das Konzept zum pflegerisch-psychiatrischen Handeln bei Auffälligkeiten, Veränderungen und Erkrankungen(NES „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ 2018“, GS MDS Essen Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und Therapie“ 2019)	

Broschüre wurde ausgehändigt: ☐ ja ☐ nein

Datum		Unterschrift Patient/ Betreuer/ Bevollmächtigter/ Angehöriger		Unterschrift PFK	
-------	--	--	--	---------------------	--

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	11	Verw., MA